



FALCON
MUN



OMS

HANDBOOK





FALCON
MUN

Alto

SECRETARIADO

Aguilar Piña María Fernanda
Benitez Hernández Ivanna
Fernández López Marco Abraham
Sánchez Bustamante Zoé



MESA DIRECTIVA



PRESIDENTA



OFICIAL DE CONFERENCIAS



MODERADORA



VICEPRESIDENTA

FALCONMUN

A stylized world map in a darker shade of blue, centered on the Atlantic Ocean, serves as the background for the text.

Mesa Directiva

Presidenta:

María Fernanda Aguilar Piña

Vicepresidenta:

Estefanía Carreño Mosqueda

Oficial de Conferencias:

Samantha García Bahena

Moderadora:

Karen Leilany Meneses Real



| FALCON
MUN

BIENVENIDA

al comité



CARTA DE BIENVENIDA

Para: Un gran delegado

Es para mí un gran honor darle la más cordial bienvenida al Modelo de Naciones Unidas de la Escuela Nacional Preparatoria N° 9 "Pedro de Alba" UNAM denominado con el nombre de FALCONMUN.

Este evento es más que un encuentro de jóvenes para debatir y negociar, es el grito de una generación que ha entendido que a nosotros los jóvenes se nos podrá arrebatar todo, menos la esperanza que nos sostiene día a día. La cual nos impulsa a ser los líderes del presente y los creadores del futuro, líderes que buscan y trabajan constantemente para un bien común, y no el de unos cuantos. FALCONMUN es un modelo que encarga ese pensamiento y principios por lo que nos complace recibirlo en este gran foro, ya que sabemos que, con su presencia, debate, negociación y ganas de hacer el cambio, haremos historia juntos.

Primeramente, le quiero agradecer por haber elegido el único comité con crisis continua, gracias por siempre dar más que los demás y ser ese extra que este mundo tanto necesita, le aseguro que no se arrepentirá.

Dentro del foro de la OMS tendremos una crisis sanitaria, que al igual que la realidad, está avanzando constantemente. Su trabajo, será contenerla, velar por su población, su seguridad sanitaria y encontrar una cura para este evento catastrófico que estará aterrando al mundo en un futuro no muy lejano. Habrá mucha crisis, descubrimientos, traiciones entre aliados y mucho más. El virus que trabajaremos estará avanzado continuamente y usted delegado, marcará que rumbo tomará esta pandemia, de usted depende que el virus se expanda por todo el mundo aniquilando a cada país y continente que encuentre... O puede levantar a su país, controlar la epidemia dentro de su nación, hallar una cura al virus y ser el héroe que este comité necesita.

Su ingenio, creatividad y capacidad para trabajar en crisis serán cruciales. De antemano sé que el delegado que está leyendo esta carta tendrá toda la capacidad de llevar un comité de esta índole. Por ello delegado, le pido que no deje que ni los nervios lo detengan de dar el mejor desempeño que pueda ofrecer dentro de este foro, no lo deje vacío ya que el mundo dependerá de sus propuestas e iniciativas para ser mejor que el día de ayer.

Siempre soñamos con hacer el cambio dentro de nuestro entorno y ser la luz que guíe a los demás dentro de la tormenta. Hoy, la tormenta es una pandemia, la pandemia del virus Neo-Nipah, un virus en constante mutación y propagación.



CARTA DE BIENVENIDA

Que de no encontrar cura acabará con el mundo entero. El mundo depende de usted, en sus manos está el futuro. Asegúrese de crear uno bueno.

¿Listo para salvar al mundo y ser los creadores del mañana? Que con usted en mi equipo sé que no estamos lejos de un futuro mejor. De ser así...

Reciba la más cordial bienvenida al comité de la Organización Mundial de la Salud por sus siglas OMS.

Atentamente:

-María Fernanda Aguilar Piña

Presidenta del Comité de la Organización Mundial de la Salud

Delegado, trabajar con usted es todo un honor.



FALCON
MUN

SOBRE

el comité





SOBRE EL COMITÉ

Introducción

La Organización Mundial de la Salud fundada en 1948, bajo una premisa revolucionaria: la salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino un estado de completo bienestar físico, mental y social. La OMS es el organismo de las Naciones Unidas que pone en contacto a naciones, asociados y personas a fin de promover la salud, preservar la seguridad mundial y servir a las poblaciones vulnerables, de modo que todo el mundo pueda alcanzar el más alto nivel posible de salud sin importar su ubicación geográfica.

Su rol principal se basa en actuar como la autoridad directiva y coordinadora de la salud internacional. Dicta las reglas para que los hospitales y gobiernos del mundo funcionen bajo los mismos estándares científicos.

La OMS lidera los esfuerzos mundiales para ampliar la cobertura sanitaria universal. Dirigir y coordinar la respuesta mundial ante las emergencias sanitarias. Promueve una vida más saludable, desde los cuidados durante un embarazo hasta la etapa de la vejez. La meta de la OMS es conocida como la de los tres mil millones que constituye un ambicioso plan para que todo el mundo disfrute de buena salud gracias a políticas y programas basados en la ciencia conocido como el **13.º Programa General de Trabajo** para el periodo **2019-2023** que debido a la pandemia de COVID-19, la Asamblea Mundial de la Salud decidió **extenderlo hasta 2025**.

Actualmente estamos regidos por el **El Decimocuarto Programa General de Trabajo** (PGT 14) **2025-2028** que se explica más adelante.

Historia

-Abril de 1945

Durante la Conferencia constitutiva de las Naciones Unidas celebrada en San Francisco dentro de los Estados Unidos de América, los representantes del Brasil y China dieron la propuesta de la creación de una organización internacional en materia de salud y para ello sería necesario convocar a una conferencia para comenzar a redactar su constitución.

-1946

El 15 de febrero de 1946, el Consejo Económico y Social (ECOSOC) encargó al Secretario General que convocara dicha conferencia. Por ello del 18 de marzo al 5 de abril de ese año se reunió en París, un comité técnico preparatorio que redactó propuestas de constitución para presentarlas a

la Conferencia Sanitaria Internacional celebrada en Nueva York del 19 de junio al 22 de julio de 1946.

Basándose en las propuestas anteriormente mencionadas, la Conferencia Sanitaria Internacional se redactó y adoptó la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que firmaron el 22 de julio de 1946 los representantes de 51 Miembros de las Naciones Unidas y de otras 10 naciones.

Además, en esta Conferencia se creó una Comisión Interina para llevar a cabo determinadas actividades de las instituciones de salud existentes hasta la entrada en vigor de la citada Constitución. Dentro de ella encontramos un preámbulo y el artículo 69 que establecen que la OMS es un organismo especializado de las Naciones Unidas, y en su artículo 80 se dispone que la Constitución entrará en vigor una vez ratificada por 26 Miembros de las Naciones Unidas.

-1948

La Constitución no entró en vigor hasta el 7 de abril de 1948, cuando la ratificaron 26 de los 61 gobiernos que la habían firmado. En la primera Asamblea de la Salud, que se inauguró en Ginebra el 24 de junio de 1948 con delegaciones de 53 de los 55 Estados Miembros, se decidió dar por concluida la Comisión Interina en la medianoche del 31 de agosto de 1948, para que fuera sucedida de inmediato por la que se llamaría la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Estructura de la OMS

Nota: La estructura de la OMS se divide en 3 partes: **Asamblea Mundial de la Salud, Consejo Ejecutivo y Secretaría.** Dentro de FALCONMUN los delegados asumirán el rol de delegados o representantes de salud ante la OMS dentro de la Asamblea Mundial de la Salud, teniendo el poder máximo de hacer y deshacer políticas e investigaciones respecto a la salud de sus países.

-La Asamblea Mundial de la Salud

La Asamblea Mundial de la Salud es el foro de más alto nivel de la OMS para la toma de decisiones. Cada año, delegados de todos los Estados Miembros que son 194, se reúnen en la Asamblea Mundial de la Salud para fijar las prioridades y trazar un rumbo para los avances en materia de salud mundial.

Un presidente dirige y modera a la Asamblea, el cual cambia cada año en mayo. El **presidente actual (78.^a Asamblea - 2025)** es el Dr. Teodoro Herbosa, actual Secretario de Salud de Filipinas.

Están los 194 Estados Miembros. Cada país envía a su Ministro de Salud o embajadores para estar presentes dentro de la Asamblea. Esta es la encargada de elegir a al Director General; Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, que lidera la organización para que alcance sus objetivos en materia de salud mundial.

-Consejo Ejecutivo

Este es el grupo que se encarga de que el Director General cumpla con sus responsabilidades dentro de las secretarías y prepara las leyes. Está formado por 34 personas técnicamente cualificadas que representan a sus países. Sus miembros se eligen para un mandato de tres años.

La principal reunión del Consejo, en la que se decide el orden del día para la siguiente Asamblea de la Salud y se adoptan resoluciones para someterlas a la Asamblea de la Salud, se celebra en enero, y una segunda reunión breve en mayo, inmediatamente después de la Asamblea Mundial de la Salud, para tratar asuntos de índole más administrativa.

Las principales funciones del Consejo Ejecutivo consisten en dar efecto a las decisiones y políticas de la Asamblea Mundial de la Salud, en asesorarla y, de manera general, en facilitar su trabajo.

Parte de su estructura se compone de la siguiente manera:

-Presidente del Consejo Ejecutivo (2025): Blair Comley (Australia).

-Mesa Directiva; personal encargado de apoyarlo:

Vicepresidenta 1: Dra. Cathrine Marie Lofthus (Noruega).

Vicepresidenta 2: Dra. Yawa Djatugbé Apétsianyi (Togo).

Vicepresidenta 3: Dr. Pongsadhorn Pokpermdee (Tailandia).

Vicepresidente 4: Mr. Fahad Abdurrahman Aljalajel (Arabia Saudita).

Relatora: Sra. Carmen Avila (Panamá).

-Secretaría

La Secretaría de la OMS se compone de expertos, funcionarios y personal sobre el terreno repartidos entre la Sede de Ginebra, las seis Oficinas Regionales y otros lugares de destino situados en más de 150 países de todo el mundo. Es el único órgano que tiene un jefe permanente y profesional.

Director General: Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. El dirige los trabajos generales pero quienes mandan son los representantes en base a lo que discutan en la Asamblea Mundial de Salud.

Dr. Tedros está encargado de liderar a la Secretaría, tomando lo que se dijo en la Asamblea Mundial de la Salud y el Consejo Ejecutivo. Con ello, divide el trabajo por **3 grandes áreas técnicas**:

1.Sede Central en Ginebra:

Todo este equipo opera desde Ginebra y es el grupo de altos cargos que asesoran directamente al Director General (Dr. Tedros) y gestionan las políticas globales. Depende directamente de la sede central de Ginebra, no de una oficina regional. Este equipo diseña las guías técnicas que usa todo el mundo. Se compone de la siguiente manera:

Jefa de Gabinete: Dra. Razia Pendse.

Director General Adjunto: Dr. Michael Ryan

Directores Ejecutivos y Científicos Jefes:

- Dr. Chikwe Ihekweazu: Director Ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias.
- Dr. Michael Ryan: Director Ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias.
- Dr. Jeremy Farrar: Científico Jefe.
- Dra. Yukiko Nakatani: Subdirectora General para Resistencia Antimicrobiana.

Directores de Áreas Técnicas y Operativas:

- Mr. Raul Thomas: Subdirector General de Gestión y Servicios (Administración, Finanzas y Recursos Humanos).
- Dra. Maria Van Kerkhove: Directora interina de Prevención y Preparación ante Epidemias y Pandemias.
- Dr. Bruce Aylward: Subdirector General de Transformación y Relaciones Externas.
- Dra. Katherine O'Brien: Directora de Inmunización, Vacunas y Productos Biológicos.
- Dr. Jérôme Salomon: Subdirector General de Cobertura Sanitaria Universal y Enfermedades Transmisibles y No Transmisibles.

2.Nivel Regional:

Una vez que la Sede de Ginebra discute las nuevas tecnologías y políticas de salud, para llevarlo al mundo y adaptarlo a cada región específica existen los 6 Directores Regionales que se encargan de aplicar la salud en sus continentes, gestionar las políticas de salud que lleguen y adecuarlas para que sean factibles para su región. Su trabajo se enfoca en la parte teórica para que posteriormente el trabajo en campo lo realice cada Nación.

Directores Regionales: Son los jefes de sus respectivas regiones y tienen un estatus muy alto ya

que son elegidos por los países de su región y no impuestos por el Director General. A pesar de su autonomía deben coordinar esfuerzos con la sede central en Ginebra. Cada región cuenta con su respectiva oficina regional. Se muestran a continuación:

- África (AFRO): Dr. Mohamed Yakub Janabi (Tanzania)
- Américas (AMRO/OPS): Dr. Jarbas Barbosa (Brasil)
- Europa (EURO): Dr. Hans Henri P. Kluge (Bélgica)
- Mediterráneo Oriental (EMRO): Dra. Hanan Balkhy (Arabia Saudita)
- Asia Sudoriental (SEARO): Sra. Saima Wazed (Bangladesh)
- Pacífico Occidental (WPRO): Dr. Saia Ma'u Piukala (Tonga)

3. Nivel de Países:

Esta es la parte de la Secretaría que vive y trabaja dentro de las fronteras de cada nación, lo que se conoce como trabajo de campo. Dirigido por la Oficina de País de la OMS (WCO por sus siglas en inglés). Cuenta con un **jefe** que será una persona **representante de la OMS** y este estará trabajando con un **equipo técnico**.

-Representante de la OMS

Cada oficina nacional está liderada por una sola persona que actúa como el embajador de la salud en ese país. Hay que entender algo importante, la OMS mediante el personal que manda a nivel nacional de cada país no pretende mandar sobre el Ministro de Salud. El Representante de la OMS no puede obligar al país a vacunar o a cerrar escuelas. Este solo podrá recomendar y brindar apoyo basados en la ciencia de Ginebra, más jamás imponer.

Para comprender mejor como funciona el trabajo en campo de la OMS a nivel nacional de cada país (este puede variar según cada Nación):

- Nombre del cargo: Se le conoce como Representante de la OMS o en inglés como WHO Representative o WR. Se encuentra de ambas formas.
- Función: Es el enlace directo entre el Dr. Tedros, el Director Regional y el Ministro de Salud del país. No es un empleado del gobierno local, sino un funcionario internacional enviado por la OMS.

-El Equipo Técnico:

Debajo del Representante, hay un equipo de profesionales que se divide por áreas prioritarias para ese país. No todas las oficinas son iguales ya que depende de las enfermedades o infecciones específicas del país. Por ejemplo, si un país tiende a tener brotes de Malaria, su equipo tendrá más expertos en esa área.

Generalmente se compone de:

- **Oficiales Nacionales Profesionales (NPOs):** Expertos locales (médicos o científicos del propio país) que conocen perfectamente el sistema de salud nacional.
- **Expertos Internacionales:** Especialistas enviados desde otros países para aportar una visión global al panorama nacional.
- **Personal Operativo:** Gente encargada de la logística, finanzas y administración para que las vacunas o suministros lleguen a donde deben.

Para finalizar, la oficina de país no trabaja aislada, se organiza en clústeres o grupos de trabajo que suelen reflejar las prioridades del Ministerio de Salud local, los clústeres se dividen para atender la salud en diferentes ámbitos y escenarios, como, por ejemplo:

- **Vigilancia Epidemiológica:** Los que analizan los datos de enfermedades cada semana.
- **Sistemas y Servicios de Salud:** Los que ayudan a que los hospitales y centros de salud funcionen en mejores condiciones.
- **Emergencias:** El equipo que se activa si hay un terremoto, una inundación o una epidemia local.

Financiamiento:

La OMS tiene un presupuesto bienal (cada 2 años). Se financia a partir de dos fuentes principales: las contribuciones señaladas de los Estados Miembros o sea, las cuotas de afiliación de los países miembros y las contribuciones voluntarias de los Estados Miembros y de otros asociados.

Las contribuciones señaladas son un porcentaje del producto interior bruto de los países este porcentaje lo acuerda la Asamblea General de las Naciones Unidas. Los Estados Miembros los aprueban cada dos años en la Asamblea Mundial de la Salud y esto tan solo cubren menos del 20% del presupuesto total.

El resto de la financiación de la OMS se realiza en forma de contribuciones voluntarias procedentes de los Estados Miembros, en gran parte, y también de otras organizaciones de las

Naciones Unidas, organizaciones intergubernamentales, fundaciones filantrópicas, el sector privado y otras fuentes. La mayoría de estas donaciones vienen con instrucciones ya que estás marcan en que se debe de ocupar el dinero donado por el país o la institución: Por ejemplo, alguien dona 10 millones, pero indica que solo se puede usar para la poliomielitis en Nigeria. Esto quita flexibilidad a la OMS.

El financiamiento de la OMS es una de las partes más críticas de su estructura, porque quien paga suele influir en las prioridades. A diferencia de una empresa, la OMS no genera dinero y vive de lo que le dan.

Sede Central de la OMS: En Ginebra, Suiza.

Metas y objetivos

Las metas y objetivos se marcan en el Decimocuarto Programa General de Trabajo (PGT 14) establece una agenda mundial de salud, que a su vez guiará la labor de la OMS en apoyo a los Estados Miembros y sus asociados durante el cuatrienio 2025-2028. Revitaliza las acciones necesarias para encaminar de nuevo los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados con la salud y ayudar a los sistemas de salud a prepararse para afrontar los retos del futuro.

La Estrategia reconoce que el mundo ha cambiado drásticamente desde la adopción de los ODS y establece una ruta ambiciosa para la salud mundial frente a desafíos clave como el cambio climático, el envejecimiento de la población, la migración y un entorno geopolítico que cambia rápidamente, así como las oportunidades que ofrecen los avances de la ciencia y la tecnología.

Habla de la cobertura total acumulada que el mundo debería tener para 2028. No están contando solo a la nueva población, sino asegurándose de que la gran mayoría de la población mundial esté bajo un sistema de salud eficaz.

El PGT 14 no intenta hacer todo, sino centrarse en acelerar lo que falta para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU para 2030. Su enfoque es la equidad: que los avances científicos no se queden solo en los países desarrollados.

Esta Estrategia se basa en los puntos fuertes del Decimotercer Programa General de Trabajo (Programa anterior) y las recomendaciones de la Evaluación del 13.º PGT . Su visión general es promover, proporcionar y proteger la salud y el bienestar de todas las personas, en todas partes.

La Estrategia Sanitaria Mundial fue adoptada por la Asamblea Mundial de la Salud en su 77ª reunión en mayo de 2024.

Dentro de este nuevo plan encontramos seis objetivos estratégicos para 2025-2028:

1. Responder al cambio climático, una amenaza creciente para la salud en el siglo XXI.
2. Abordar los determinantes de la salud y las causas fundamentales de la mala salud en políticas clave en todos los sectores.
3. Promover el enfoque de atención primaria de salud y las capacidades esenciales del sistema de salud para lograr la cobertura sanitaria universal.
4. Mejorar la cobertura de los servicios de salud y la protección financiera para abordar la inequidad y las desigualdades de género.
5. Prevenir, mitigar y prepararse ante los riesgos para la salud derivados de todos los peligros.
6. Detectar rápidamente y mantener una respuesta eficaz a todas las emergencias sanitarias.

La OMS desempeña un papel único, en el centro de la arquitectura sanitaria mundial, para facilitar, habilitar y garantizar el impacto de esta nueva y audaz estrategia para la salud y el bienestar a nivel mundial. Alcanzar esta ambición requiere la financiación completa, sostenible y previsible del presupuesto base de la Organización para el período 2025-2028. Esta inversión en la OMS es vital para garantizar que, para finales de 2028, la labor de la Secretaría, junto con los Estados Miembros y los asociados, permita los siguientes resultados:

- 6.000 millones de personas gozarán de mejor salud y bienestar;
- 5 mil millones de personas se beneficiarán de la cobertura sanitaria universal sin dificultades financieras;
- 7.000 millones de personas estarán mejor protegidas ante las emergencias sanitarias.

Para alcanzar estos objetivos, el mundo debe aprovechar la oportunidad del período 2025-2028 para avanzar en la equidad sanitaria, volver a encaminar los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con la salud y preparar los sistemas de salud y las comunidades para el futuro, protegiéndolos contra los inevitables choques y desafíos de la era posterior a los ODS.

Este texto es clave, ya que es el grito de auxilio de la OMS. Para alcanzar las cifras dadas anteriormente de 5, 6 y 7 mil millones, la OMS le está diciendo a los países que no se podrá proteger a 7,000 millones de personas si el presupuesto depende de donaciones voluntarias y caprichosas. Se necesita que el presupuesto base esté 100% financiado de forma previsible.

Este es el primer programa que se lanza tras la gran crisis del COVID-19, por lo que tiene un nivel de urgencia política que los anteriores no tenían. Por eso se le llama el plan de la "recuperación y resiliencia".

Países miembros

1. Estados Unidos de América
2. Canadá
3. Estados Unidos Mexicanos
4. República Federativa de Brasil
5. República de Colombia
6. República Argentina
7. República Italiana
8. República Francesa
9. República Federal de Alemania
10. Reino de España
11. Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
12. República Popular China
13. Japón
14. República de Singapur
15. República de Corea
16. República de Filipinas
17. República de la India
18. Mancomunidad de Australia
19. Nueva Zelanda
20. República de Indonesia
21. República de Turquía
22. República de Sudáfrica
23. República de Polonia
24. República de Chile
25. República de Perú
26. República de Vietnam
27. Reino de Tailandia
28. República de Serbia
29. República Checa
30. Confederación Suiza



SOBRE EL COMITÉ

Facultades del Comité:

- Actuar como autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad internacional;
- Establecer y mantener colaboración eficaz con las Naciones Unidas, los organismos especializados, las administraciones oficiales de salubridad, las agrupaciones profesionales y demás organizaciones que se juzgue convenientes;
- Ayudar a los gobiernos, a su solicitud, a fortalecer sus servicios de salubridad y proporcionar ayuda técnica adecuada, en casos de emergencia, prestar a los gobiernos la cooperación necesaria que soliciten, o acepten;
- Proveer o ayudar a proveer, a solicitud de las Naciones Unidas, servicios y recursos de salubridad a grupos especiales, tales como los habitantes de los territorios fideicometidos;
- Establecer y mantener los servicios administrativos y técnicos que sean necesarios, inclusive los epidemiológicos y de estadística;
- Estimular y adelantar labores destinadas a suprimir enfermedades epidémicas, endémicas y otras;
- Promover, con la cooperación de otros organismos especializados cuando fuere necesario, la prevención de accidentes;
- Promover la cooperación entre las agrupaciones científicas y profesionales que contribuyan al mejoramiento de la salud;
- Proponer convenciones, acuerdos y reglamentos y hacer recomendaciones referentes a asuntos de salubridad internacional, así como desempeñar las funciones que en ellos se asignen a la Organización y que estén de acuerdo con su finalidad;
- Promover y realizar investigaciones en el campo de la salud;
- Promover el mejoramiento de las normas de enseñanza y adiestramiento en las profesiones de salubridad, medicina y afines;
- Estudiar y dar a conocer, con la cooperación de otros organismos especializados, cuando fuere necesario, técnicas administrativas y sociales que afecten la salud pública y la asistencia médica desde los puntos de vista preventivo y curativo, incluyendo servicios hospitalarios y el seguro social;
- Suministrar información, consejo y ayuda en el campo de la salud;
- Contribuir a crear en todos los pueblos una opinión pública bien informada en asuntos de salud;
- Establecer y revisar, según sea necesario, la nomenclatura internacional de las enfermedades, de las causas de muerte y de las prácticas de salubridad pública;
- Establecer normas uniformes de diagnóstico, según sea necesario.



| FALCON
MUN

TÓPICO ÚNICO:

Respuesta global
ante la mutación y
propagación
pandémica del virus
Neo-Nipah.



TÓPICO ÚNICO: Respuesta global ante la mutación y propagación pandémica del virus Neo-Nipah.

INTRODUCCIÓN

Información conocida sobre el virus previo a la mutación.

La enfermedad del virus Nipah es una enfermedad infecciosa zoonótica, esto quiere decir que se trata de una infección que se transmite de animales a seres humanos. El agente es el virus Nipah (NiV), ataca animales como cerdos, caballos, perros y gatos.

Esta enfermedad apareció por primera vez en cerdos domésticos en Malasia y Singapur en 1998 y 1999, y resultó en la necesidad de sacrificar a más de un millón de cerdos para ser controlada. Después de los brotes iniciales en Malasia y Singapur en la década de 1990, se empezaron a detectar casos en humanos que se infectaron con el virus Nipah a través del contacto cercano con cerdos infectados y sus residuos.

Esta infección se caracteriza por su alto potencial zoonótico, se ha esparcido a través del contacto con otros individuos infectados o la exposición a murciélagos infectados. Esto debido a que el huésped reservorio natural del virus Nipah son los murciélagos frugívoros, provenientes del sureste asiático, encontrando el virus en la orina de los murciélagos y potencialmente en sus heces, saliva y fluidos de parto.

El virus Nipah, en humanos, provoca una variedad de presentaciones clínicas, desde infecciones asintomáticas hasta síntomas respiratorios agudos o encefalitis mortales.

-Historia

Durante los brotes de 1998-1999 en Malasia, se sospechó que los murciélagos introdujeron el virus en los criaderos de cerdos, posiblemente a través de la ingestión de alimentos y agua contaminados con desechos de murciélago por parte de los cerdos. En los criaderos de cerdos, la infección puede propagarse de un cerdo a otro por contacto directo, así como a otros criaderos de cerdos a través del transporte del virus en fómites (insectos que pueden portar y propagar enfermedades y agentes infecciosos) o reservorios, en este caso, ropa, equipos, botas, vehículos, etc.

Después, la transmisión a los humanos se produjo principalmente por contacto directo con las excreciones o secreciones de cerdos infectados. Posteriormente se registraron brotes en Bangladesh e India, que sugieren una transmisión directa desde los murciélagos, sin un huésped intermedio, mediante la ingesta de alimentos contaminados con secreciones de murciélago, como la savia de palma cruda o frutas, que al estar en los árboles fueron contaminados con excrementos de murciélago.

En 2014 surgió un brote de Nipah en Filipinas, atacando a humanos, se atribuyó su contagio al contacto directo con fluidos contaminados durante el sacrificio de caballos infectados y la ingestión de carne poco cocida. Tiempo después se informó de casos de Nipah en humanos, asociados con un contacto cercano y prolongado con un individuo infectado.

Reporte Clínico:

Precauciones necesarias:

- a) Cuidado para las personas responsables de pacientes infectados.
- b) Precauciones al enviar y manipular muestras de laboratorio de casos sospechosos.
- c) Medidas para aquellos que trabajan en estrecha colaboración con animales susceptibles y mataderos en áreas de riesgo.

Bioseguridades: Son fundamentales para prevenir la infección en animales domésticos.

- a) Disminuir la probabilidad de que el reservorio de murciélagos entre en contacto con animales susceptibles.
- b) En áreas infectadas, mantener alejados a los cerdos y caballos de las plantaciones de árboles frutales.
- c) No se deben alimentar a los animales con frutas que hayan podido estar en contacto con murciélagos.
- d) Los veterinarios y criadores de animales deben mantenerse alerta, y los casos sospechosos o confirmados deben ser informados a las Autoridades Veterinarias.

Protección en humanos:

- a) Reducir el contacto con murciélagos y sus secreciones.
- b) Elaborar prácticas higiénicas exhaustivas como lavar frutas y verduras antes de consumirlas, mantener una buena higiene de manos después de manipular o preparar estos alimentos y asegurarse de usar recipientes cubiertos al recolectar la savia de palma, seguido de hervirla antes de ser consumida.
- c) Educar y proporcionar equipo de protección personal (EPP) a las personas en contacto con animales potencialmente infectados.

Datos estadísticos recaudados (Marzo, 2024):

1. Tasa de mortalidad: 40% - 75 % de personas aproximadamente.
2. Aparición de síntomas: De 4 a 14 días posteriores a la exposición del virus.
3. Complicaciones: Encefalitis y por ende muerte potencial.
4. Síntomas comunes: Fiebre, cefalea, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar y vómito.

Es importante mencionar que la encefalitis puede progresar a un coma en menos de 48 horas. Sus síntomas son desorientación, somnolencia y convulsiones.

Importancia de dialogar sobre su propagación global:

Es preocupante, la OMS tiene bajo vigilancia el virus dada su elevada letalidad, ausencia de tratamiento específico y de vacunas y potencial de contagio.

TÓPICO ÚNICO: Respuesta global ante la mutación y propagación pandémica del virus Neo-Nipah.

Desgraciadamente la OMS no pudo controlar el virus... No hay una cura para el y a principios de 2025, se encontró una nueva variante del virus, recibió el nombre de Neo-nipah y se esparció rápidamente provocando una emergencia sanitaria a nivel global. Este suceso dejó en jaque a la OMS ya que de no resolverlo la seguridad sanitaria estará totalmente devastada a nivel no solo del sureste asiático, sino del mundo entero.

Esta variante se apega a los datos que ya conocemos, es decir, ocuparemos la información clínica previamente mencionada que servirá de contexto para el buen flujo del debate, sin embargo, si hay ciertas modificaciones en cuanto a la **sinomatología y problemáticas**, lo que se mencionará más adelante.

Factores más importantes que diferencian a esta mutación:

Inicialmente se reportaron patrones de neumonía y encefalitis. La problemática central de este virus es la tendencia a desarrollar encefalitis severa y complicaciones respiratorias.

1) Encefalitis: Cuando las infecciones o las afecciones médicas afectan al cerebro y la médula espinal activan el sistema inmunitario, esto puede provocar inflamación del mismo, denominada encefalitis. La inflamación en sí puede provocar una amplia gama de síntomas. En casos extremos, puede resultar en daño cerebral, accidente cerebrovascular o incluso la muerte.

Síntomas de encefalitis:

- a) Problemas del habla o de la audición.
 - b) Visión doble o pérdida de la visión.
 - c) Fiebre alta y/o repentina.
 - d) Alucinaciones.
 - e) Pérdida del conocimiento.
 - f) Pérdida de sensibilidad en algunas partes del cuerpo.
 - g) Alteraciones en la función motora, incluidos movimientos espasmódicos incontrolables de la cabeza, el tronco o las extremidades (llamados espasmos mioclónicos).
 - h) Parálisis parcial en brazos y piernas.
 - i) Alteración del juicio y personalidad.
 - j) Convulsiones.
 - k) Pérdida de la memoria.
 - l) Coma.
-

Diagnóstico:

El proveedor de atención médica realiza un examen físico y de antecedentes médicos para revisar las actividades de los últimos días o semanas y detectar posibles causas (exposición reciente a insectos, garrapatas o animales, contacto con personas enfermas o viajes recientes, afecciones médicas preexistentes y medicamentos). Se realizan pruebas de diagnóstico para confirmar la presencia de infección o inflamación. El diagnóstico temprano es vital, ya que los síntomas pueden aparecer repentinamente y alcanzar el daño cerebral, la pérdida de la audición y/o del habla, ceguera o incluso la muerte.

Tratamiento:

Incluye fármacos antivirales, antibióticos, corticosteroides y otros fármacos, según la causa. Para los tipos graves de encefalitis donde, como en este caso, no existe una vacuna o un medicamento, el tratamiento de apoyo (reposo, nutrición y líquidos) puede ayudar al cuerpo a combatir la infección y aliviar los síntomas. Los fármacos antivirales como aciclovir y ganciclovir pueden tratar la encefalitis infecciosa causada por un virus. Sin embargo, no existen tratamientos específicos disponibles para la mayoría de los virus que causan encefalitis por lo que es necesario tratamiento médico de inmediato.

2) Aumento en la transmisibilidad respiratoria: Aumentó significativamente la transmisión de persona a persona, a través de microgotas en contextos de atención médica y ambientes cerrados. Esta variante adquirió mutaciones en la proteína G (de adhesión) lo que permitió que se uniera más fácilmente a receptores ephrin B2 y ephrin B3 en células epiteliales que recubren el tracto respiratorio humano. En consecuencia, el virus se puede replicar de forma masiva en nariz, garganta y pulmones. Se liberan gotas muy pequeñas al toser y hablar, sumando que la atención médica es en espacios cerrados, se infectó rápidamente a muchas personas.

Detección de la variante.

Durante los brotes iniciales en contagios masivos y en pruebas posteriores se encontró una altísima carga viral en hisopado nasal. Esta prueba se lleva a cabo tomando una muestra de células del interior de las fosas nasales o de la nasofaringe, la parte superior de la nariz y la garganta.

Etapas iniciales, primeros casos.

Se detectaron casos secundarios entre familiares, cuidadores y personal de salud, la variante se propagó rápidamente por vía respiratoria.

Finales 2025 - principios 2026.

Exportación de casos a otros países a partir de los viajes, las personas continuaban sus traslados pensando que se trataba solo de un resfriado y en consecuencia se desataron múltiples focos simultáneos de contagio.

OMS declara emergencia de salud pública y más tarde la declarará pandemia debido a la afectación global sostenida.

Poblaciones en riesgo:

- a) Adultos mayores.
- b) Pacientes inmunocomprometidos, ocasionado por la debilidad de su sistema inmunitario y la ausencia de glóbulos blancos que combaten la infección, por lo que tiene un avance que va desde una fiebre a sepsis hasta un fallecimiento. Las personas pueden tener problemas para eliminar la infección de sus cuerpos, es decir, una infección con sintomatología simple puede tardar más en curarse o tener mayores complicaciones.
- c) Personas embarazadas.
- d) Personal sanitario expuesto a secreciones.
- e) Personas que trabajan de cerca con cerdos infectados.
- f) Familiares y cuidadores de pacientes con Neo-nipah.
- g) Personas expuestas a comida o bebida contaminada o que fue extraída de animales infectados.

Reservorios para vigilar:

Zonas periurbanas con interacción humano-pecuario y zonas con presencia de murciélagos frugívoros, mercados y granjas.

Signos tempranos del virus Neo- Nipah:

- 1. Fiebre
- 2. Cefalea
- 3. Mialgia
- 4. Tos.
- 5. Malestar general

Complicaciones de la variante:

- a) Desencadena una progresión acelerada de insuficiencia respiratoria por lo que el personal médico se ve en la necesidad de intubar a los pacientes. Y encefalitis, misma que provoca convulsiones, alteración en la conciencia y deja secuelas neurológicas en los sobrevivientes.
- b) Se caracteriza por una encefalitis fulminante: Inflamación en el cerebro en menos de 48 hrs que provoca fiebre alta, convulsiones y pérdida de conciencia.
- c) Edema cerebral severo: Aumenta la presión intracraneal que conduce al coma y muerte en pocos días.

Problemática de detección tardada:

La falta de detección temprana representa un riesgo, debido a la gran variedad de síntomas que fácilmente se pueden confundir con resfriado u otra infección viral.

Sin embargo, esta detección temprana es crucial para aumentar las probabilidades de sobrevivencia y prevenir su transmisión.

Secuelas:

- a) Epilepsia post- infecciosa debido a los traumatismos cerebrales.
- b) Parálisis parcial o dificultades motoras.
- c) Trastornos cognitivos: pérdida de la memoria, problemas de concentración y deterioro del lenguaje (afasia).
- d) Alteraciones psiquiátricas: psicosis inducida por el daño neurológico.
- e) Cambios en la personalidad como irritabilidad, apatía, agresividad o problemas emocionales.

Rehabilitación integral:

Debe incluir rehabilitación cognitiva, fisioterapia, terapia del habla y terapia ocupacional. Además, se requerirá rehabilitación neurológica prolongada por meses u años. Los pacientes dependen de un tratamiento de fisioterapia y terapia ocupacional y psicológica, ventilación asistida nocturna o apoyo de oxígeno.

DESARROLLO

En noviembre de 2025, tras el registro de 56 nuevos casos del virus Nipah en Kerala, India, el Instituto de Salud Global de la Universidad de Wisconsin decidió trasladar la muestra del virus a Estados Unidos, donde inició una investigación urgente para desarrollar una vacuna o tratamiento efectivo, la investigación comenzó como un esfuerzo preventivo, pero se convirtió en el punto de quiebre de una crisis mundial.

Durante las pruebas en laboratorio, los investigadores detectaron una mutación inesperada del virus, más agresiva y con capacidad de transmisión aérea entre humanos a pesar de tener un origen zoonótico, denominaron la nueva mutación como “Neo-Nipah”, posteriormente, uno de los investigadores entró en contacto directo con la cepa mutada sin saberlo por lo que continuó con su rutina diaria: utilizó el transporte público, compartió almuerzo con sus colegas, asistió a una conferencia y regresó a casa con su familia.

Debido a la alta transmisión de la mutación, en menos de una semana los primeros síntomas aparecieron, en él y en su círculo cercano; en menos de un mes, la ciudad de Madison reportaba cientos de casos y como se esperaba, la mutación se propagó con una velocidad alarmante por la Costa Este, alcanzando Nueva York, Boston y Washington D.C.

Fue en diciembre de 2025, el flujo de turismo tuvo un aumento significativo, ocasionando que el virus cruzara fronteras masivamente convirtiéndose en vectores involuntarios, en cuestión de semanas, se reportaron brotes en los cinco continentes.

El 9 de enero de 2026, la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente el estado de pandemia global, Estados Unidos acumulaba más de 2 millones de casos y una tasa de mortalidad del 19 %, así mismo, el sistema hospitalario colapsó en múltiples estados, y las medidas de contención se vieron obstaculizadas por divisiones políticas y desinformación.

Ante este panorama globalizado de casos y contagios masivos, cada región del planeta vivió el impacto del Neo-Nipah de forma distinta, las respuestas fueron tan diversas como sus realidades: desde colapsos sanitarios y brotes descontrolados, hasta redes de resistencia comunitaria y avances científicos inesperados.

A continuación, se presentan breves perfiles regionales para orientar a los delegados en el análisis del rol de sus países:

América del Norte: **Estados Unidos**, cuando se registraron los primeros brotes, el gobierno no actuó con seriedad por lo que no cerró sus fronteras en fechas de fiestas decembrinas, la falta de medidas provocó brotes descontrolados en más de 20 estados, con hospitales colapsados y millones de contagios en menos de tres meses; registrando para el 9 de enero de 2026 aproximadamente 2 millones de casos y 400,000 muertes. A lo largo de los siguientes años, el país enfrentó protestas, crisis sanitaria prolongada y tensiones entre gobiernos estatales y federales, pese a su rol en el origen del brote, Estados Unidos logró avances científicos clave en vacunas y tratamientos antivirales que marcaron la respuesta global.

Canadá, al detectar los primeros brotes en Wisconsin, cerró sus fronteras terrestres especialmente con los estados del norte de E.U., a pesar del cierre, el virus llegó por vía aérea; Toronto reportó casos y pronto hubo brotes en Montreal y Vancouver. La respuesta fue rápida: cuarentenas rurales, suspensión de vuelos internos y activación de protocolos sanitarios federales, en 2026, Canadá acumulaba más de 600,000 casos y 50,000 muertes, pero logró estabilizar su sistema hospitalario antes que EE. UU.



América Latina y el Caribe: América Latina recibió la primera oleada del virus “Neo-Nipah” en enero de 2026, con brotes simultáneos en **México, Brasil, Colombia y Argentina**, estas regiones enfrentaron la pandemia con sistemas de salud debilitados ocasionando saturación hospitalaria y una alta tasa de mortalidad en zonas rurales, afectando a adultos mayores, personal sanitario y personas embarazadas. Ante esto, las comunidades latinoamericanas formaron redes comunitarias, brigadas médicas y campañas de vacunación, muchas de ellas en colaboración con la OPS (Organización Panamericana de la Salud).

Europa: Entre 2026 y 2028, Europa enfrentó dos oleadas de Neo-Nipah con brotes masivos en **Italia, Francia, Alemania, España y Reino Unido**, la rápida saturación hospitalaria obligó a cerrar fronteras a mediados de 2026, generando tensiones internas y una respuesta fragmentada. A pesar de que Reino Unido ya no formaba parte de la Unión Europea, colaboró en la creación del Centro Europeo de Bioseguridad y en el establecimiento de un fondo común para investigación médica, esta alianza científica permitió acelerar el desarrollo de vacunas y protocolos de contención, posicionando a Europa como un bloque clave en la reconstrucción sanitaria global.

Asia Oriental y Sudoriental: Las delegaciones de **China, Japón, Singapur, Corea del Sur y Filipinas** enfrentaron los brotes del virus con respuestas sanitarias rápidas, países como China, Japón y Corea activaron cuarentenas masivas, construyeron hospitales temporales y se apoyaron de la inteligencia artificial para gestionar recursos y hacer investigaciones. Singapur, se convirtió en modelo de eficiencia, con protocolos de bioseguridad urbana y cooperación científica con universidades internacionales, Filipinas a pesar de que atravesó dificultades, logró contener los brotes mediante redes comunitarias y apoyo regional.



India: India fue uno de los países más afectados por la pandemia de Neo-Nipah, con brotes masivos en ciudades como Mumbai y Delhi provocando que la saturación hospitalaria, la falta de personal médico y la desigualdad en el acceso a servicios básicos agravara mucho más su situación. Aunque en 2027 desarrolló la primera vacuna efectiva, millones de personas quedaron sin cobertura ni atención médica, actualmente el sistema de salud sigue debilitado, y muchas regiones dependen de brigadas voluntarias y donaciones internacionales para sobrevivir por lo que la recuperación ha sido lenta y desigual, con comunidades rurales aún sin acceso a tratamientos ni infraestructura básica.

Oceanía: Durante los brotes de 2026 y 2027, **Australia y Nueva Zelanda** lograron contenerlos mediante protocolos sanitarios estrictos, cierre de fronteras y sistemas de rastreo digital apoyados por inteligencia artificial. Ambos países enfrentaron tensiones internas por el acceso desigual a tratamientos en zonas rurales y comunidades vulnerables, Nueva Zelanda destacó por su enfoque ético y comunitario, priorizando la salud pública y la transparencia informativa mientras que Australia, impulsó la producción de antivirales, aunque fue criticada por priorizar exportaciones sobre tener una cooperación regional.

La emergencia sanitaria provocada por el virus Neo-Nipah ha expuesto las fragilidades de los sistemas de salud y la carencia de acuerdos multilaterales sólidos para enfrentar amenazas biológicas por lo que es imperativo consolidar un marco global de bioseguridad que combine prevención, detección temprana y respuesta coordinada a futuras crisis sanitarias.

Por ello, la Organización Mundial de la Salud convoca a sesionar los días 21, 22 y 23 de enero del presente año para revisar y actualizar los protocolos internacionales de bioseguridad, abordando temas de vigilancia epidemiológica, el intercambio oportuno de datos y la movilidad controlada de personal y suministros médicos.



OBJETIVOS DEL COMITÉ (enfocados en el tópico):

Como objetivo principal en este comité prevalece la iniciativa por desarrollar conciencia colectiva respecto a emergencias sanitarias posibles.

Gracias a la pandemia del virus SARS-CoV-2 nos hemos dado cuenta de la importancia de diseñar medidas precautorias, protocolos de evacuación, aislamiento y atención de enfermedades. Es necesario sumar esfuerzos colectivos desde cada nivel institucional y cada sector poblacional para diseñar protocolos de seguridad y atención a las enfermedades.

Reconociendo que los virus emergentes no respetan fronteras ni discriminan comunidades es indispensable una respuesta coordinada. Como habitantes de este mundo, mismos que permanecen en constante interconectividad debemos fomentar la responsabilidad compartida de los Estados miembros en la prevención y control de pandemias.

Buscamos implementar mejoras en el sistema de salud actual, ya que reconocemos su efectividad, pero también sus carencias que son limitantes para un servicio de adecuada calidad en especial para los sectores más periféricos y/o empobrecidos. Y nuestros objetivos incluyen: identificar debilidades en cuanto a la infraestructura hospitalaria, capacidad de cuidados intensivos y acceso a medicamentos y material requerido.

También, proponer planes de inversión en salud pública que garanticen la rentabilidad para las medidas y necesidades frente a brotes de alta letalidad. En este sentido exhortamos a la modificación de los presupuestos designados en materia de salud pública.

A su vez buscamos que se afinen detalles y especificaciones acerca de las normas de calidad que debe seguir la distribución de productos alimentarios para garantizar la salud del consumidor. Esto incluye medidas sanitarias en su extracción y transporte, así como controles de calidad como requisito para que los alimentos sean liberados a su venta.

Reiteramos nuestro compromiso con la democratización de los servicios de atención médica. Estableciendo estrategias que aseguren que las poblaciones de atención prioritaria tengan acceso a pruebas, tratamientos y vacunas.

Medidas de regulación en la interacción de animales con humanos para reducir la propagación de enfermedades zoonóticas. Es pertinente impulsar una regulación estricta en mercados de animales y control de bioseguridad.

Se busca la creación de protocolos de respuesta rápida ante pandemias, es decir, la realización de planes de contención inmediata que incluya cierre de fronteras, períodos estratégicos de aislamiento y espacios designados disponibles para actuar en caso de una emergencia de esta índole.

En cuanto al periodo post - pandemia, debemos proponer mecanismos de cooperación para la reconstrucción de los sistemas de salud, integrando programas de rehabilitación neurológica y respiratoria, considerando que las secuelas de esta pandemia afectaran con daños irreversibles la calidad de vida de los sobrevivientes. Por ello es necesario incorporar apoyo psicológico que sea accesible y no se concentre solamente en zonas donde es posible pagarlo, además de cuidados paliativos y programas para la reintegración social.

Es de gran importancia Incentivar la cooperación y el diálogo internacional para el eficiente tratamiento de los afectados, y la movilización de equipos médicos de emergencia. Impulsar tratados globales en cuanto la designación de presupuestos para la investigación, preparación y respuesta a pandemias.

Para terminar, deseamos que esta simulación sirva de ejercicio para prevenir y establecer medidas anticipatorias que definitivamente son y serán necesarias para cualquier situación de riesgo.

En conclusión, debemos fomentar el trabajo en equipo para la prevención (campañas educativas sobre la vacunación y medidas de control), tratamiento eficaz y distribuido, control, y rehabilitación social y en cuanto a infraestructura para futuras pandemias.

PREGUNTAS GUÍA:

- ¿Qué mecanismos puede establecer la OMS para garantizar el acceso equitativo a vacunas y tratamientos en contextos de desigualdad global?
- ¿Qué alianzas políticas tiene mi delegación?
- ¿Cómo pueden las delegaciones mejorar la colaboración en futuras investigaciones?
- ¿Cómo mitigar el impacto económico de las medidas de contención en países en desarrollo?
- ¿Qué estrategias pueden tomar las delegaciones para garantizar la seguridad sanitaria global, proteger los derechos humanos frente a cuarentenas, cierres fronterizos y control digital de la población sin afectar la economía local?
- ¿Qué objetivos y aportaciones tiene mi delegación para el desarrollo y contención de virus en caso de una crisis sanitaria?
- ¿Qué estrategias de cooperación internacional se pueden implementar para proteger a poblaciones vulnerables (refugiados, migrantes climáticos, países en conflicto)?
- ¿Qué colaboración internacional es necesaria para frenar una pandemia?
- ¿Qué función deberían tener los actores no estatales (ONGs, farmacéuticas, sector privado) en la contención de una crisis sanitaria?
- ¿Cómo pueden las delegaciones asegurar que las investigaciones y desarrollo tecnológico para la contención del virus sea sostenible y responsable?

PUNTOS A DEBATIR:

Refieren a subtemas concretos que los delegados deberán discutir y negociar en las sesiones en materia de salud, tecnología, economía, derechos humanos, cooperación.

- Distribución equitativa de vacunas, antivirales y equipos médicos.
 - Prevención de futuras pandemias: control de laboratorios, seguridad en investigación genética y bioética.
 - Regulación y cooperación en el uso de inteligencia artificial para el rastreo y diagnóstico de la pandemia.
 - Creación de un fondo global permanente para emergencias sanitarias futuras.
 - Estrategias para garantizar la estabilidad económica de las regiones afectadas.
 - Estrategias para combatir la desinformación y las noticias falsas relacionadas con la enfermedad.
 - Protección de derechos humanos frente a medidas restrictivas (cuarentenas, vigilancia digital, pasaportes sanitarios).
 - Estrategias de cooperación internacional para proteger a poblaciones vulnerables (refugiados, migrantes climáticos, países en conflicto)
-



FALCON
MUN

REFERENCIAS

REFERENCIAS

Acerca de la OMS. (s. f.). <https://www.who.int/es/about>

Historia. (s. f.). <https://www.who.int/es/about/history>

Constitución. (s. f.). <https://www.who.int/es/about/governance/constitution>

Estructura organizativa de la OMS. (s. f.). <https://www.who.int/es/about/structure>

Thirteenth General Programme of Work. (s. f.). <https://www.who.int/about/general-programme-of-work/thirteenth>

Fourteenth General Programme of Work. (s. f.). <https://www.who.int/about/general-programme-of-work/fourteenth>

Cómo se financia la OMS. (s. f.). <https://www.who.int/es/about/funding>

Quiénes somos. (s. f.). <https://www.who.int/es/about/who-we-are>

Coronavirus disease (COVID-19) pandemic. (2025, 13 octubre). <https://www.who.int/europe/emergencies/situations/covid-19>

World Health Organization: WHO. (2020, 10 enero). Coronavirus. https://www.who.int/es/health-topics/coronavirus#tab=tab_1

World Health Organization: WHO. (2018, 30 mayo). Virus de Nipah. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/nipah-virus>

World Health Organization: WHO. (2018a, mayo 30). Nipah virus. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/nipah-virus>

El ABC del virus Nipah. (2024, 10 julio). OPS/OMS | Organización Panamericana de la Salud. <https://www.paho.org/es/noticias/10-7-2024-abc-virus-nipah>



FALCON
MUN



ELABORADO POR:

María Fernanda Aguilar Piña
Estefanía Carreño Mosqueda
Samantha García Bahena
Karen Leilany Meneses Real